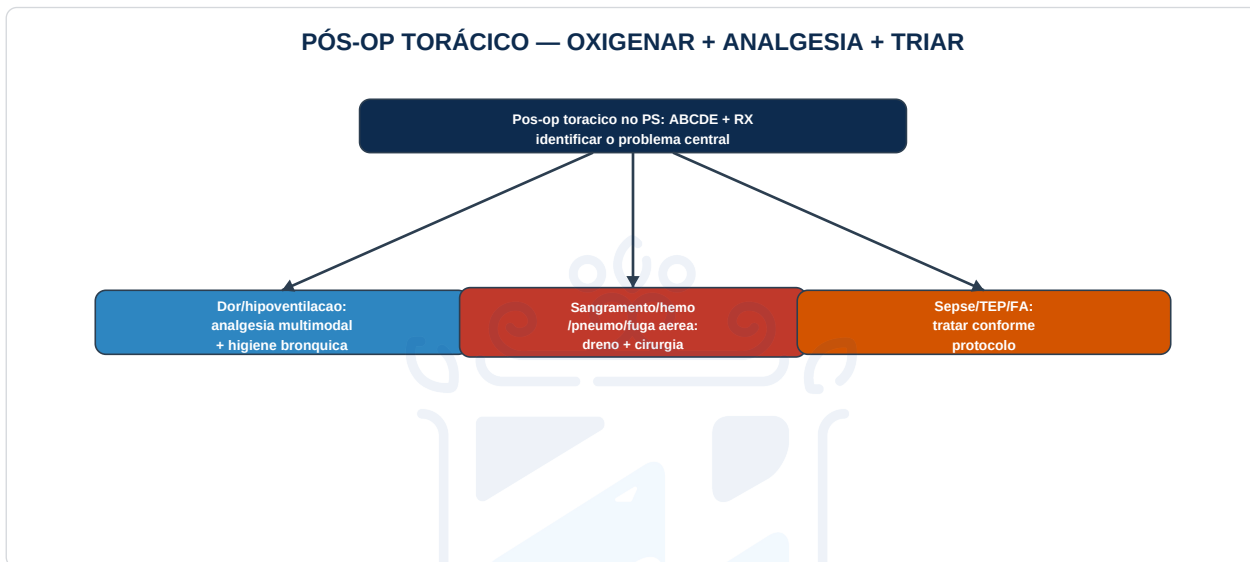


PÓS-OP TORÁCICO — DOR, DRENO E COMPLICAÇÕES

FLUXOGRAMA — IDENTIFICAR O PROBLEMA CENTRAL



COMPLICAÇÕES POR JANELA TEMPORAL

Período	Complicações
24-72h	Dor intensa -> hipoventilação/atelectasia/hipoxemia; sangramento/hemotórax; pneumotórax/fuga aérea, enfisema subcutâneo; insuf. respiratória; FA pós-op; problemas do dreno
3-10 dias	Atelectasia/pneumonia; derrame reacional/loculado, empiema; TEP/TVP; deiscência, náusea/constipação por opioide
Semanas (pós-alta)	Dor neuropática/intercostal pós-toracotomia; infecção de sítio; derrame persistente, quilotórax, fístula broncopleurar tardia

AValiação E O DRENO QUE CHEGA AO PS

ANAMNESE DIRIGIDA

- Qual cirurgia e quando? (VATS x toracotomia; ressecção/pleurodese/decorticação/trauma); lado operado; intercorrências
- Tem DRENO? tipo, débito recente, aspecto (seroso/sanguinolento/leitoso), 'borbulhamento' (fuga aérea)
- ATENÇÃO: paciente NÃO recebe alta com dreno tubular em selo d'água. Se chega drenado no PS, em geral tem VÁLVULA DE HEIMLICH (unidirecional), conectada ao dreno tubular ou a um dreno fino (PIGTAIL/Wayne/Pneumovalve)
- Sintomas: dispneia, dor, febre/calafrios, tosse/expectoração, HEMOPTISE, síncope, dor pleurítica
- Comorbidades/risco: DPOC/asma, cardiopatia, anticoagulante, neoplasia, tabagismo; analgesia/ATB/profilaxia de TEV em uso

EXAME FÍSICO E EXAMES

O QUE BUSCAR

- Sinais vitais, FR/SpO2, perfusão, temperatura; padrão ventilatório, musculatura acessória; ferida (eritema/secreção/deiscência); dreno (fixação, dobras, obstrução); ENFISEMA subcutâneo
- Ausculta/percussão: MV reduzido unilateral, crepitações, roncos; cardiovascular (ritmo irregular = FA, congestão); MMII (TVP)
- RX de tórax: pneumotórax, derrame/hemotórax, atelectasia, pneumonia, POSIÇÃO do dreno
- ECG (dispneia/dor/palpitação/idoso); labs conforme quadro (hemograma, PCR, eletrólitos/renal, gaso se hipoxemia, lactato se sepse, troponina se dor/ECG alterado)
- TC (± angio-TC) se suspeita de TEP, hemotórax/coleção não explicada, piora desproporcional ou dúvida de complicação cirúrgica

ANALGESIA MULTIMODAL (PERMITE TOSSIR/VENTILAR)

Rx BASE -> OPIOIDE SE NECESSÁRIO

Base: Dipirona 1 g VO/EV 4-6/6h OU Paracetamol 750-1000 mg 6-8/8h
AINE por curto período se sem contraindicação renal/GI/hemorragica: Ibuprofeno 400-600 mg 8/8h ou Cetoprofeno 100 mg 12/12h — EVITAR AINE se houve PLEURODESE recente
Opioide se a dor impede ventilar/tossir: Tramadol 50-100 mg 6-8/8h ou Morfina 2-4 mg EV (repetir a cada 10-15 min até controlar; monitorar sedação/FR)
Adjuvantes: antiemético (Ondansetrona 4 mg 8/8h) + laxativo se opioide (Lactulose 10-20 mL 8-12/12h)
A boa analgesia é o que previne atelectasia/pneumonia (permite respiração profunda e tosse)

EMERGÊNCIAS — SANGRAMENTO, PNEUMOTÓRAX, TEP, DRENO

RED FLAGS E CONDUTA

- SANGRAMENTO/HEMOTÓRAX: palidez, hipotensão/taquicardia, queda de Hb, aumento rápido do débito sanguinolento no dreno -> ABC, 2 acessos, tipagem/prova cruzada, Hb seriado, reposição; acionar cirurgia torácica (pode exigir reabordagem)
- PNEUMOTÓRAX/FUGA AÉREA: RX; checar o sistema do dreno (conexões, dobras, obstrução, frasco abaixo do tórax); grande pneumo + instabilidade = emergência (descompressão/drenagem)
- ENFISEMA subcutâneo extenso SEM repercussão ventilatória: geralmente conservador — discutir com torácica/UTI
- TEP/TVP: dispneia desproporcional, taquicardia, dor pleurítica, dessaturação inexplicada, síncope -> angio-TC e anticoagulação (avaliar risco, discutir com cirurgia)
- PROBLEMAS DO DRENO: exteriorizou/saiu -> curativo OCLUSIVO + RX imediato; desconectou -> assepsia + restabelecer selo d'água; sem oscilação/sem débito com piora -> suspeitar obstrução (mas nem todo dreno sem oscilação é problema)

FEBRE/PNEUMONIA E ARRITMIA (FA PÓS-OP)

Rx OUTRAS FRENTES

Febre/tosse/suspeita de pneumonia: RX + hemograma/PCR ± gaso; antibiótico conforme gravidade/protocolo (pós-op recente e internação aumentam risco de germes hospitalares)
Higiene brônquica: incentivo respiratório, fisioterapia, nebulização com SF se secreção espessa, mobilização precoce
Sepse/instabilidade -> protocolo de sepse + UTI
FA pós-operatória (comum): ECG + corrigir gatilhos (dor, hipoxemia, distúrbio eletrolítico, infecção); controle de frequência se estável; instabilidade -> cardioversão e suporte avançado
Não esquecer profilaxia/avaliação de TEV

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR/observar em sala crítica: necessidade de O₂/hipoxemia/fadiga respiratória; dor que impede ventilar apesar de analgesia; pneumotórax/hemotórax/complicação do dreno; sangramento/instabilidade/queda de Hb; pneumonia moderada-grave/seps; FA sintomática; suspeita de TEP; pós-op recente (< 7 dias) ou cirurgia maior (lobectomia/pneumonectomia) com sintomas
- ☐ ALTA possível se TODOS: estável, SpO₂ adequada em ar ambiente/basal, dor controlada VO sem limitação ventilatória, RX sem complicação que exija observação, orientações de alarme + retorno com a equipe cirúrgica
- ☐ Casa: Dipirona/Paracetamol ± AINE 3 dias ± Tramadol/Codeína; incentivo respiratório + caminhadas curtas; curativo conforme orientação
- ☐ Orientações de alarme: piora da dispneia, febre persistente, dor progressiva, dessaturação, síncope, hemoptise, confusão
- ☐ Retorno definido (idealmente contato com a equipe cirúrgica)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Cirurgia: VATS/toracotomia — procedimento ____, lado ____, data ____; queixa principal e evolução ____.
- Dreno: () não () sim — tipo (tubular/Heimlich/pigtail) ____, débito ____ mL/h, aspecto ____, fuga aérea ____.
- ABCDE: PA/FC/FR/SpO₂/T ____; achados: MV reduzido, crepitações, enfisema subcutâneo, FA no ECG ____; RX/TC ____; Hb/leuco/PCR/gaso ____.
- Motivo: () hipoxemia () sangramento/hemotórax () pneumotórax/fuga aérea () seps/pneumonia () arritmia () suspeita TEP () complicação do dreno -> solicito torácica/UTI.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Por que a analgesia multimodal é prioritária no pós-operatório de cirurgia torácica?

- A) Apenas por conforto
- B) Porque a dor causa hipoventilação, levando a atelectasia, hipoxemia e pneumonia; a analgesia permite respiração profunda e tosse eficaz
- C) Para reduzir o tempo de cirurgia
- D) Para evitar arritmias exclusivamente
- E) Não é prioritária

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Um paciente pós-toracotomia chega ao PS com dreno exteriorizado (saiu). Qual a conduta imediata?

- A) Recolocar o dreno às cegas
- B) Curativo oclusivo no orifício + radiografia de tórax imediata
- C) Apenas observação
- D) Clampear e liberar
- E) Aspirar pelo orifício

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sinais de palidez, hipotensão, taquicardia e aumento rápido do débito sanguinolento no dreno sugerem:

- A) Atelectasia
- B) Sangramento/hemotórax — acionar cirurgia torácica e repor volume
- C) Constipação por opioide
- D) Infecção urinária
- E) Dor neuropática

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual analgésico deve ser EVITADO em paciente submetido a pleurodese recente?

- A) Dipirona
- B) AINE (anti-inflamatório não esteroidal)
- C) Paracetamol
- D) Tramadol
- E) Morfina

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual arritmia é comum no pós-operatório de cirurgia torácica e exige correção de gatilhos (dor, hipoxemia, eletrólitos)?

- A) Bloqueio AV total
- B) Fibrilação atrial
- C) Taquicardia ventricular sustentada
- D) Bradicardia sinusal
- E) Síndrome de Brugada

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A dor pós-toracotomia causa hipoventilação e tosse ineficaz, levando a atelectasia, hipoxemia e pneumonia; por isso a analgesia multimodal é prioritária — permite respiração profunda e higiene brônquica.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Dreno exteriorizado: aplica-se curativo oclusivo no orifício e faz-se RX de tórax imediato para avaliar pneumotórax; aciona-se a equipe cirúrgica.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Palidez, hipotensão, taquicardia e débito sanguinolento crescente indicam sangramento/hemotórax: ABC, acessos, prova cruzada, Hb seriado, reposição e acionamento da cirurgia torácica (possível reabordagem).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Após pleurodese recente, evita-se o AINE, pois sua ação anti-inflamatória pode prejudicar a aderência pleural desejada pelo procedimento.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A fibrilação atrial é a arritmia mais comum no pós-op torácico; o manejo inclui corrigir gatilhos (dor, hipoxemia, distúrbios eletrolíticos, infecção) e controlar a frequência (ou cardioverter se instável).

SM24
Suporte ao Plantão Médico